COLUMNA DE VISIÓN

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Estefanía Rodríguez Izquierdo, Juan José Gutiérrez Adrián, M. Rocío Delgado Díaz

CONSIDERACIONES

En la **torre de visión** se integra el módulo central de control de todo el sistema robótico. Está compuesta por:

- Monitor de pantalla táctil.
- Dispositivo de insuflación de CO_2.
- Unidad electroquirúrgica.
- Sistema de procesamiento de imágenes.
- Núcleo de control del robot.



El monitor de pantalla táctil, y la unidad electroquirúrgica están en notas aparte.

El sistema de procesamiento de imágenes y el núcleo robótico están compuestos por tres unidades:

- El controlador del endoscopio, que proporciona una iluminación de alta intensidad y controles de video del endoscopio.
- El procesador de video, que permite un procesado de video adicional y la grabación de imágenes.
- La electrónica del sistema o core, que es el punto central de conexión donde se enrutan todos los componentes del sistema robótico.

CONEXIONES



De la torre de visión salen tres cables azules. Dos de ellos van a las consolas y el otro al carro del paciente. Todos los aparatos deben mantener el botón de atrás encendido, normalmente no se apagan.

El cable gris que sale es el del sistema de CO_2.

También hay tres cables de alimentación que hay que conectar: de la consola del Airseal, del electrocoagulador y de la cámara. El resto no deben manipularse para nada.

MODO SIMULACIÓN



La consola 2 es la que lleva el simulador. Para ponerla en modo simulación hay que conectar a la consola del cirujano uno de los extremos del cable que está habitualmente guardado formando un bucle (uniéndola al lugar donde se conecta cable azul que une todas las partes del robot). El resto de los cables azules deben permanecer desconectados cuando la consola está en este modo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Da Vinci Xi Surgical System In-Service Guide: OR Staff. https://www.lmc-clients.com/intuitive/2023/Resources/StaffingGuide/1007573-09-USrD-Xi-ORstaff-InServiceGuide-OS4v9.pdf